

Case 1 (acute cholecystitis):

40 y/o M

Vital sign: T/P/R: 38.5/98/16, SpO2: 99% BP 123/81 mmHg

C.C.: Fever with RUQ abdominal pain for 1 day

Past history: nil

Allergy: nil

Level: 3

Case 2 (AfRVR)

76 y/o F

C.C. : Palpitation and chest tightness for half day

Vital sign: T/P/R: 36.5/150/16, SpO2: 98% BP 102/68 mmHg

Past history: arrhythmia, hyperlipidemia

Allergy: peanut

Level: 2

Case 3: (pneumonia)

80 y/o M

C.C.: Dyspnea for 2 days

Vital sign: T/P/R: 38.5/102/23, SpO2: 92% BP 123/81 mmHg

Past history: DM, HTN

Allergy: penicillin

Level: 2

Case 4: URI

26 y/o F

C.C: Fever for 2 days, cough and runny nose

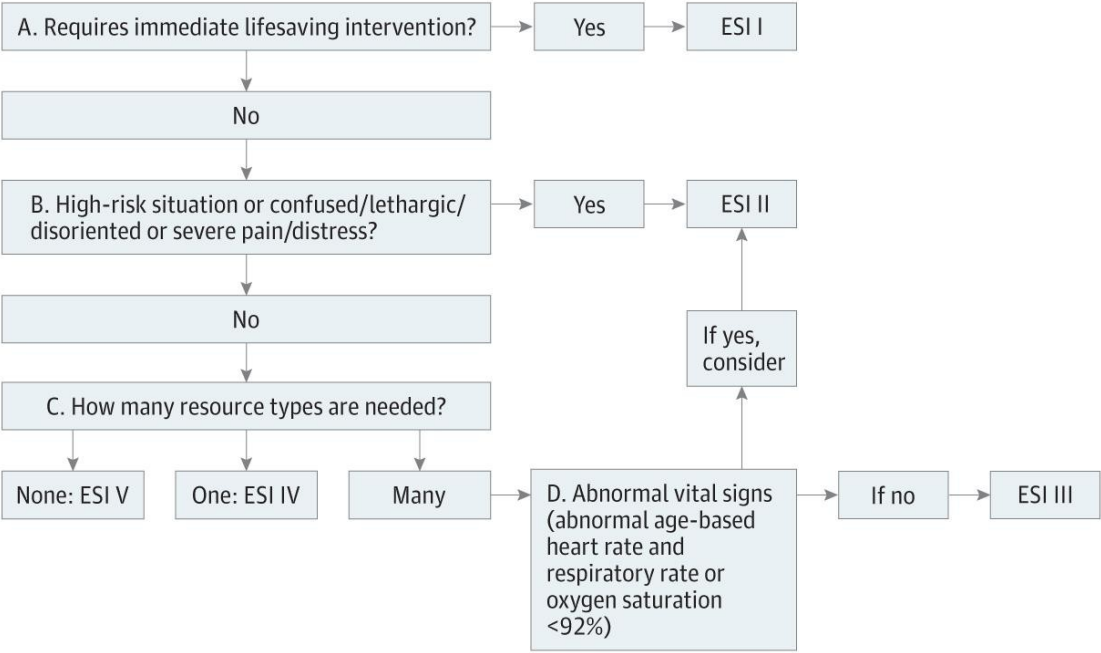
Vital sign: T/P/R: 37.5/98/21 SpO2:98% BP 124/76 mmHg

Past history: nil

Allergy: nil

Level 5

ESI triage algorithm



五級急診檢傷和台灣擊破度分級量表(Taiwan Triage And Acuity Scale, TTAS) **時間重要！**

	安全候診時間	定義	病患常見表現
 第一級 復甦急救 (Resuscitation)	立即	病況危急，生命或肢體需 <u>立即處置</u>	心跳停止/休克 嚴重呼吸困難 意識狀態改變 GCS≤9 持續抽搐 到院前死亡
第二級 危急(Emergent)	10 分鐘	潛在性危急生命、肢體及器官功能狀況，需 <u>快速控制與處置</u>	心因性心絞痛 急性明顯吐血現象 高血壓(收縮壓>200 或舒張壓>110)， <u>伴隨呼吸困難症狀</u> 嚴重中樞性疼痛(8-10) GCS: 10~13 急性或突然視覺改變
第三級 緊急(Urgent)	30 分鐘	病況可能 <u>持續惡化需要急診處置</u> 或伴隨明顯不適的症狀 <u>影響日常活動</u>	心因性疼痛 <u>已緩解</u> /有典型心因性病史 咖啡色嘔吐物或黑便 高血壓(SBP>200 或 DBP >110) <u>沒有任何症狀</u> 中度中樞性疼痛(4-7) 抽搐後意識 <u>已恢復</u>
第四級 次緊急(Less urgent)	60 分鐘	病況可能是 <u>慢性疾病的急性發作</u> 或某些疾病之 <u>合併症</u> 相關，需要在 1-2 小時做處置，以 <u>求恢復避免惡化</u>	有心悸的 <u>病史或心悸已緩解</u> 局部蜂窩性組織炎 泌尿道症狀 急性咳嗽 生命徵象正常 周邊中度疼痛(4 - 7)
第五級 非緊急(Not urgent)	2 小時	病況為非緊急狀況，需做 <u>鑑別性的診斷</u> 或轉介門診以避免後續之惡化	慢性咳嗽，生命徵象正常 轉診 換藥 局部紅疹